

EJERCICIO TERAPÉUTICO DE MC. KENZIE



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

EJERCICIOS DE MC. KENZIE

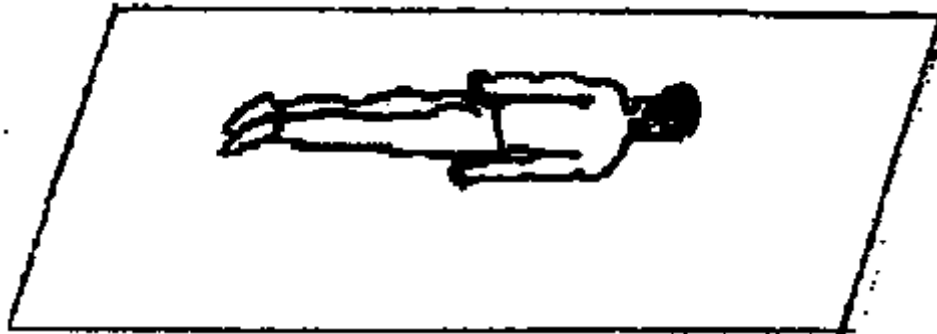
- Son ejercicios de extensión, que **incrementan la movilidad** de la columna.
 - Restauran la lordosis lumbar
-
- ✓ Fortalecen los músculos espinales
 - ✓ Se realizan con repeticiones de 10 a 15 veces
 - ✓ Mantener esfuerzo durante 1 a 2 segundos en el arco de movimiento máximo
 - ✓ Realizar con ritmo continuo y cada esfuerzo debe ir seguida de un periodo de relajación

JUSTIFICACIÓN

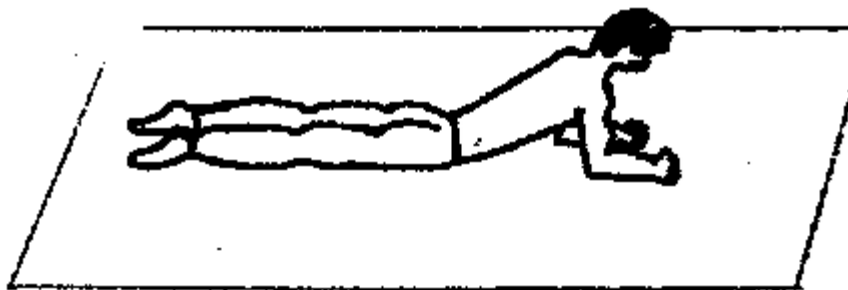
1. Disminuir el dolor, mediante la liberación temporal de la presión
2. Fortalecimiento de los músculos debilitados
3. Disminuye el estrés mecánico
4. Estabiliza segmentos hipomóviles
5. Mejora la postura y la movilidad

EJERCICIOS

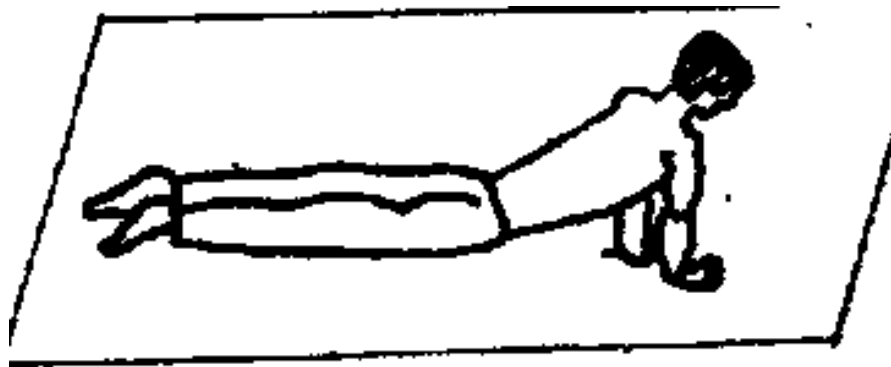
1. **Decúbito prono:** Brazos a los lados de cada cuerpo y la cabeza hacia un lado (en donde la columna produce unos grados de lordosis).



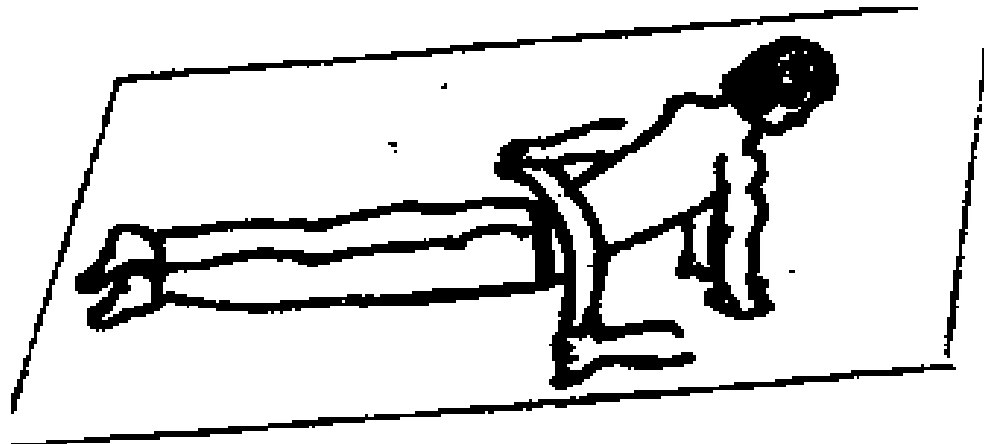
2. Extensión en decúbito prono: El paciente en posición prona coloca los codos bajo los hombros y eleva la parte superior de su cuerpo de tal manera que se apoya en los codos y antebrazos mientras la pelvis y muslos permanecen sobre la mesa (la lordosis se incrementa).



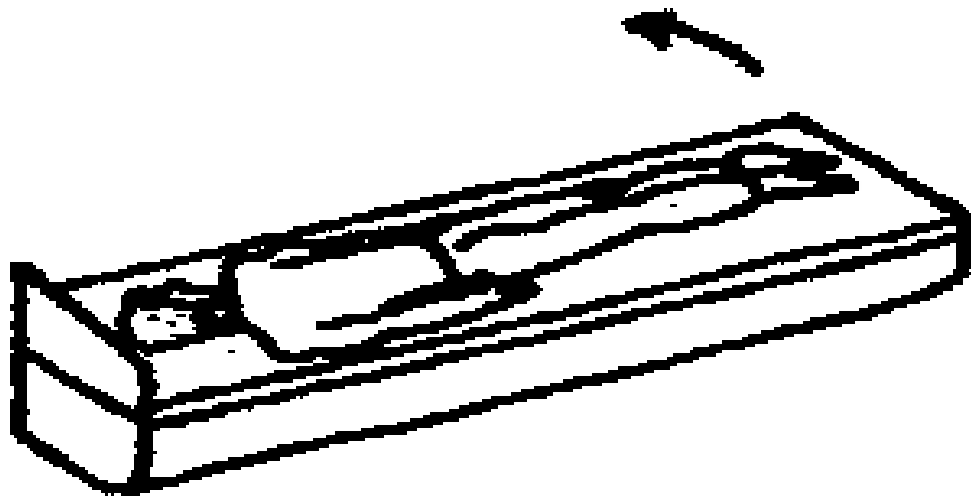
3. Extensión desde la posición de decúbito prono: paciente en posición de “lagartija” en donde el paciente se siente seguro lograra la extensión completa de los brazos.



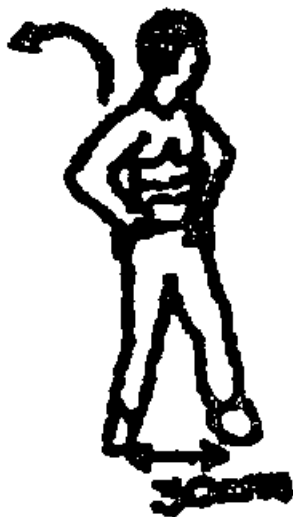
4. Extensión en decúbito prono y fijación por medio de cinturón: Misma posición que el ejercicio 3 solo que este ejercicio se coloca un cinturón a nivel de “glúteos” para fijar la pelvis.



5. Extensión sostenida: El paciente se coloca en posición prona su cabeza al final de la mesa, la cual se eleva gradualmente, casi de 1 a 2 pulgadas por períodos de 5 a 10 minutos; una vez que el grado máximo de extensión es alcanzado la posición puede ser mantenida por 2 a 10 minutos de acuerdo a la tolerancia del paciente.



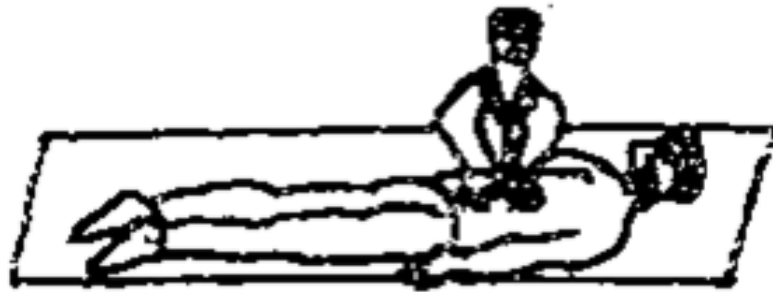
6. Extensión en bipedestación: El paciente de pie con los pies separados colocando las manos en la región lumbosacra, se extiende la columna tanto como sea posible.



7. Movilización en extensión: paciente colocado como en el **procedimiento 1**. El terapeuta coloca la base de la mano sobre los procesos transversos del segmento lumbar, una presión gentil es aplicada. Cada presión en menos intensa que las previas.



8. Manipulación en extensión: Paciente en posición prona, el terapeuta coloca las manos a un lado de la columna como en la técnica 7, el paciente se apoya sobre el paciente con los brazos a la derecha de la angulación de la columna y la fuerza lentamente hacia abajo hasta que la columna se sienta tensa, entonces una alta velocidad de empuje de muy corta amplitud es aplicada e inmediatamente liberada.



9. Movilización rotatoria en extensión: misma posición que el **ejercicio 7**, en donde la presión es aplicada primero en los procesos transversos, sobre un lado y luego sobre el otro lado con lo que se tiene un efecto de balanceo.



10. Manipulación rotatoria en extensión: El paciente en decúbito prono, el terapeuta a un lado y colocando las manos a cada lado de la columna como en el procedimiento 9, en donde el terapeuta únicamente refuerza la maniobra.



11. Rotación sostenida/movilización en flexión: paciente en decúbito supino, las piernas son llevadas al frente del terapeuta alejando su hombro del paciente, el cual es mantenido firmemente sobre la superficie, produciendo con esto estabilización y fijación. Con la otra mano el terapeuta flexiona la cadera y las rodillas en ángulo recto, produciendo con esto la rotación de la columna lumbar. Tobillo apoyado sobre la mesa. El paciente aplica una mayor presión para reducir el remanente de debilidad en la columna lumbar.



12. Manipulación rotatoria en flexión: seguir el **procedimiento 11**, se aplica una presión súbita o empuje de alta velocidad y de amplitud corta es desarrollada, moviendo la columna dentro de la inclinación lateral y la rotación.



13. Flexión en decúbito supino: paciente colocado en decúbito supino con rodillas y cadera flexionadas aproximadamente 45° y los pies colocados con apoyo total sobre el colchón, el paciente lleva sus rodillas hacia el tórax y aplica máxima presión con sus manos sobre la rodilla.



14. Flexión en bipedestación: El simple ejercicio de tocarse las puntas de los pies estando en bipedestación con los pies separados 30cms.



15. Flexión sobre un solo pie: Paciente parado sobre una sola pierna y la otra pierna descansando sobre una silla a 90°, el paciente se flexiona, y si es posible el hombro debe ser llevado más debajo de la rodilla.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN